TOME 20 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique

Collèges CUESP / Thérapeutique / Médecine Légale • 523 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 20 : Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 523 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collèges CUESP / Thérapeutique / Médecine Légale.
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	523 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 20

Collèges CUESP / Thérapeutique / Médecine Légale • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 20 • Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique (523 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

PARTIE 1 — SANTÉ PUBLIQUE

- Chapitre 01 : 3. Médecine fondée sur des preuves
- Chapitre 02 : 4. Infections nosocomiales
- Chapitre 03 : 4. Qualité, Sécurités des soins
- Chapitre 04 : 5. Responsabilités médicales, Gestion des erreurs
- Chapitre 05 : 6. Organisation de l'exercice clinique
- Chapitre 06 : 16. Organisation du système de soins
- Chapitre 07 : 17. Télémédecine
- Chapitre 08 : 18. Santé numérique
- Chapitre 09 : 19. Protection sociale
- Chapitre 10 : 20. Méthode de la recherche en santé
- Chapitre 11 : 21. Mesure de l'état de santé de la population
- Chapitre 12 : 59. Sujet en situation de précarité
- Chapitre 13 : 145. Surveillance des maladies infectieuses transmissibles
- Chapitre 14 : 179. Risques liés à l'eau et l'alimentation
- Chapitre 15 : 181. Veille sanitaire
- Chapitre 16 : 323. Analyser les résultats des études cliniques

PARTIE 2 — MÉDECINE LÉGALE - HUMANITÉ

- Chapitre 17 : 7. Droits du patient
- Chapitre 18 : 9. Éthique médicale
- Chapitre 19 : 11. Violences et santé
- Chapitre 20 : 12. Violences sexuelles
- Chapitre 21 : 13. Certificats médicaux, Décès
- Chapitre 22 : 14. La mort

PARTIE 3 — MÉDECINE DU TRAVAIL

- Chapitre 23 : 180. Risques sanitaires liés aux irradiations
- Chapitre 24 : 182. Environnement professionnel et santé au travail

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

PARTIE 1 — SANTÉ PUBLIQUE

Chapitre 01 : 3. Médecine fondée sur des preuves
Chapitre 02 : 4. Infections nosocomiales
Chapitre 03 : 4. Qualité, Sécurités des soins
Chapitre 04 : 5. Responsabilités médicales, Gestion des erreurs
Chapitre 05 : 6. Organisation de l'exercice clinique
Chapitre 06 : 16. Organisation du système de soins
Chapitre 07 : 17. Télémédecine
Chapitre 08 : 18. Santé numérique
Chapitre 09 : 19. Protection sociale
Chapitre 10 : 20. Méthode de la recherche en santé
Chapitre 11 : 21. Mesure de l'état de santé de la population
Chapitre 12 : 59. Sujet en situation de précarité
Chapitre 13 : 145. Surveillance des maladies infectieuses transmissibles
Chapitre 14 : 179. Risques liés à l'eau et l'alimentation
Chapitre 15 : 181. Veille sanitaire

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Niveau de preuve scientifique	Appréciée lors de la synthèse des résultats de l'ensemble des études sélectionnées -> constitue la conclusion des tableaux de synthèse de la littérature
Gradation du niveau de preuve scientifique	Gradation du niveau de preuve scientifique repose sur 3 éléments : - Existence de données de la littérature pour répondre aux questions posées - Niveau de preuve des études disponibles - Cohérence de leurs résultats
Niveau de preuve d'une étude	Capacité d'une étude à répondre à la question posée, dépend des caractéristiques suivantes : - Schéma de l'étude - Adéquation de l'étude à la question posée - Adaptation de l'analyse statistique aux objectifs de l'étude - Existence de biais dans la planification ou la conduite de l'étude - Puissance de l'étude et en particulier la taille de l'échantillon utilisé
Si divergence de résultat entre études	En cas de divergence des r■sultats, il appartient aux « experts » de pond■rer les e■tudes en fonction de leur niveau de preuve, de leur nombre, et pour des e■tudes de me■me niveau de preuve en fonction de leur puissance -> Accord d'experts si approbation de ≥ 80% des membres du groupe de travail

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Facteurs conditionnant le niveau de preuve	- Schéma de l'étude - Adéquation de l'étude à la question posée - Adaptation de l'analyse statistique aux objectifs de l'étude - Existence de biais dans la planification ou la conduite de l'étude - Puissance de l'étude et en particulier la taille de l'échantillon utilisé
Facteurs ne conditionnant pas le niveau de preuve ■■	- Ne dépend pas du type d'étude entre étude de supériorité ou de non-infériorité - Ne dépend pas du résultat positif ou négatif de l'étude - Ne dépend pas de la pertinence clinique ou non du critère de jugement principal
Attention	Selon le collège de thérapeutique, un CDJ non pertinent n'influe pas sur le niveau de preuve, par contre il va influer sur la pertinence clinique Pertinence de la question posée (objectif) qui dépend de : -> Critères de jugement choisis (doivent être importants pour le patient) -> Choix de la population d'étude -> Nature de l'intervention évaluée -> Choix du traitement contrôle (comparateur) -> Pertinence de la durée de suivi

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 20

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 20 • Santé Publique, Médecine Légale & Thérapeutique (523 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collèges CUESP / Thérapeutique / Médecine Légale
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (523 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.